1ª Edición - 2025

GUIA DE MANEJO DE ANTIBIÓTICOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

EQUIPO PROA

Autores

María Arrieta Loitegui (Farmacia Hospitalaria), Laura Jiménez Navarro (Farmacia Hospitalaria), Paula Ortega Menéndez (Farmacia Hospitalaria), Jaime Esteban Moreno (Microbiología Clínica), Marta López de las Heras (División Enfermedades Infecciosas-Medicina Interna), Elizabet Petkova Saiz (División Enfermedades Infecciosas-Medicina Interna)

PROA Fundación Jiménez Díaz

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Grupo quirónsalud

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
AMIKACINA	**Vía iv.:** 15-20 mg/kg/24h	**FG 40-60 ml/min:** 15-20 mg/kg/36h **FG 20-40 ml/min:** 15-20 mg/kg/48h **FG < 20 ml/min:** administrar dosis de carga y determinar las siguientes dosis e intervalo según las concentraciones séricas	**Vía iv.:** 25-30 mg/kg/24h Dosis recomendadas en pacientes críticos o infecciones graves	**FG 40-60 ml/min:** 25-30 mg/kg/36h **FG 20-40 ml/min:** 25-30 mg/kg/48h **FG < 20 ml/min:** administrar dosis de carga y determinar las siguientes dosis e intervalo según las concentraciones séricas	**HD:** IM, IV: 5 a 12,5 mg/kg/dosis 3 veces por semana después de la diálisis en los días de diálisis. **DP:** IM, IV: Inicial: 5 a 12,5 mg/kg/dosis cada 48 a 72 horas. **TRRC:** CVVH/CVVHD/CVVHDF: IV: Inicial: 15 a 25 mg/kg cada 48 horas.	El riesgo de toxicidad hepática es elevado. Evitar su empleo si es posible	**Monitorizar concentraciones séricas para ajuste de dosis (valorar IC a farmacia)** **Criterios para monitorizar:** función renal inestable o FG elevado (fibrosis quística, politraumatizados, jóvenes…), volumen de distribución alterado (tercer espacio, ascitis, cirrosis, quemados, obesidad, embarazadas, ventilación mecánica),alto riesgo de nefrotoxicidad (>65 años, otros fármacos nefrotóxicos, pacientes críticos), >5 días de tratamiento, objetivo de niveles elevados **Extracción de 1ª muestra:** en 2ª dosis (pico y valle) **Frecuencia de monitorización:** - Pacientes estables y con niveles adecuados: control cada 4 días - Pacientes críticos o tras ajuste de dosis: después de 2-3 días - Si aumento de Cr ≥ 0.5 mg/dL o mala respuesta a la terapia **Nivel valle recomendado:** <1 mg/L o indetectable. Medir antes de administrar la siguiente dosis **Nivel pico recomendado:** 30-40 mg/L En pacientes críticos, sospecha de infección de origen pulmonar y neutropénicos se pueden aceptar picos de 45-60 mg/L Medir 30 min tras el fin de la infusión de 30 min

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
AMOXICILINA	**Vía iv.:** 1 g/6-8h	**FG 10-30 ml/min:** 500 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 500 mg/24h	**Vía iv.:** 2 g/4h - Meningitis	**FG 10-30 ml/min:** 500 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 500 mg/24h	**Si dosis recomendada 250-500 mg/8h** HD: 250-500 mg/12 a 24h DP: 250-500 mg/12h **Si dosis recomendada 875-1000 mg /12h** HD: 500 mg/12 a 24h DP: 500 mg/12h **Si dosis recomendada 1000mg/8h** HD: 500 mg/12h DP:500mg/12h	No requiere ajuste. Dosificar con precaución y monitorizar la función hepática a intervalos regulares	
	Vía oral: 500 mg/8h		**Vía oral:** 750 mg-1 g/8h	**FG 10-30 ml/min:** 1 g/12h **FG < 10 ml/min:** 500 mg/12h			
AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO	**Vía iv.:** 1 g/200 mg/6-8h	**FG 10-30 ml/min:** Dosis inicial de 1.000/200 mg y después 500/100 mg/12h **FG < 10 ml/min:** Dosis inicial de 1.000/200 mg y después 500/100 mg/24h	**Vía iv.:** 2 g/200 mg/8h	**FG 10-30 ml/min:** Dosis inicial de 1.000/200 mg y después 500/100 mg/12h **FG < 10 ml/min:** Dosis inicial de 1.000/200 mg y después 500/100 mg/24h	**HD:** Dosis carga 1 g seguido de 500 mg / 12 a 24 h. **DP:** Dosis carga 1 g seguido de 500 mg / 12 h	No requiere ajuste. Dosificar con precaución y monitorizar la función hepática a intervalos regulares	
	Vía oral: 500 mg/125 mg/8h	**FG 10-30 ml/min:** 500/125 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 500/125 mg/24h	**Vía oral:** 875 mg/125 mg/8h	**FG 10-30 ml/min:** 500/125 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 500/125 mg/24h	**HD:** 250 a 500 mg/12 a 24h **DP:**250-500 mg12h		
AMPICILINA	**Vía iv.:** 1-2 g/4-6h	**FG 30-50 ml/min:** 1-2 g/8h **FG 15-30 ml/min:** 1-2 g/12h **FG < 15 ml/min:** 1-2 g/24h	**Vía iv.:** 2 g/6h (2 g/4h en meningitis, bacteriemia, endocarditis, IOA)	**FG 30-50 ml/min:** 2 g/6h **FG 15-30 ml/min:** 2 g/8h **FG < 15 ml/min:** 2 g/12h	**Si dosis recomendada 1-2g/6h** **HD y DP:** 1-2g/24h **Si dosis recomendada 2g/4h** **HD y DP:** 2g/12h	No requiere ajuste	
	Vía oral: 250-2000mg cada 8/12h según indicación.				**Si dosis recomendada 500 mg/6h** **HD y DP:** 500 mg/12 a 24h		

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
AZITROMICINA	**Vía iv.:** 500 mg/24h **Vía oral:** 250-500 mg/24h. Dosis única 1g en algunas indicaciones	**FG < 10 ml/min:** emplear con precaución	No hay	No hay	No requiere ajuste	Usar con precaución en pacientes que padezcan una enfermedad hepática significativa. Se han notificado casos de hepatitis fulminante que potencialmente pueden provocar fallo hepático	
AZTREONAM	**Vía iv.:** 1-2 g/8-12h	**FG 10-30 ml/min:** 1 g como dosis inicial, seguido de 500 mg/8h o 1g/12h **FG < 10 ml/min:** 1 g como dosis inicial, seguido de 250 mg/8h o 1g/24h	Vía iv.: 2 g/6h administradas en perfusión de 2h - Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I - Infecciones sistémicas graves	**FG 10-30 ml/min:** 2 g como dosis inicial, seguido de 1 g/6-8h o 2g/12h **FG < 10 ml/min:** 2 g como dosis inicial, seguido de 500 mg/6-8h o 2g/24h	**Si dosis recomendada 1g/8h** HD y DP: 1g/24h **Si dosis recomendada 2g/6-8h** HD y DP: 2g/24h **TRRC:** 2 g dosis única seguida de 1 g/8 horas o 2 g/12 horas	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** evitar dosis altas durante periodos prolongados Se recomienda reducción de dosis del 20-25% para tratamiento a largo plazo de pacientes con enfermedad hepática crónica con cirrosis y cuando también la función renal esté alterada	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Tiempo de infusión:** 2h

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
CEFAZOLINA	**Vía iv.:** 1 g/8-12h	Dosis de carga inicial sin reducción **FG 35-54 ml/min:** 1 g/8h **FG 11-34 ml/min:** 500 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 500 mg/18-24h	**Vía iv.:** 2 g/8h	Dosis de carga inicial sin reducción **FG 35-54 ml/min:** 2 g/8h **FG 11-34 ml/min:** 1 g/12h (algunos expertos recomiendan 2g/12h en infecciones graves) **FG < 10 ml/min:** 1 g/18-24h	**HD** (tres veces por semana): IV: **Dosis diaria:** 500 mg - 1 g / 24h (cuando la dosis programada cae en un día de diálisis, administrar después de la diálisis). **Dosificación tres veces por semana** (después de la diálisis): 2 g o 20 mg/kg (dosis máxima: 2 g) después de la diálisis 3 veces por semana o 2 g tras diálisis si la próxima diálisis se espera en 48h o 3 g tras diálisis si la próxima diálisis se espera en 72h. **DP:** IV: 500 mg / 12h o 1 g / 24h. **TRRC:** **CVVH/CVVHD/CVVHDF: IV:** dosis de carga de 2 g seguida de 1 g/8h o 2 g/12 h.	No requiere ajuste	
CEFDITORENO	**Vía oral:** 200-400 mg/12h	**FG 30-50 ml/min:** 200 mg/12h **FG <30 ml/min:** 200 mg/12h	No hay	No hay	**HD:** 200 mg/24h (el día de la diálisis, después de la sesión) **DP:** 200 mg/24h	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** no se dispone de datos	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
CEFEPIME	**Vía i.v.:** 2 g/12h o 1 g/8h	**FG 30-60 ml/min**: 1 g/12-24h **FG 11-29 ml/min:** 500 mg-1 g/24h **FG < 11 ml/min:** 250-500 mg/24h	Vía iv.: 2 g/8h - Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I (en perfusión extendida) - Infecciones intrabdominales complicadas - Empírico en neutropenia febril	**FG 30-60 ml/min:** 2 g/12h **FG 11-29 ml/min:** 1 g/12h o 2 g/24h **FG < 11 ml/min:** 1 g/24h	**HD** (tres veces por semana): IV: 1 g dosis única, seguido de 500 mg-1g/24h. Si la dosis habitual con funcion renal normal es 2g/8h o 1g/6h, se emplearía 1g/24h; 500 mg/24h para todas las demás. **DP:** 1g/24h **CVVH/CVVHD/CVVHDF:** IV: 2 g / 8 a 12 h.	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Bolo inicial:** 2 g en 30 min **Tiempo de infusión del resto de dosis:** 3h
CEFIDEROCOL	**Vía i.v.**: 2 g/8h en perfusión extendida. En pacientes con aclaramiento renal >120ml/min, 2g/6h	**FG 30-60 ml/min:** 1,5 g/8h **FG 15-30 ml/min:** 1 g/8h **FG < 15 ml/min:** 750 mg/12h	No hay	No hay	**HD:** 750 mg/12h (administrar después de la sesión de diálisis) **TRRC:** **CVVH/CVVHD/CVVHDF: IV:** dosis en función del flujo <2L/h : 1,5 g/12; 2-2,5 L/h: 2 g/12h; 3-3,5 L/h: 1,5 g/8h; 4-5 L/h: 2 g/8h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Bolo inicial:** 2 g en 30 min en sepsis **Tiempo de infusión del resto de dosis :** 3h
CEFIXIMA	**Vía oral:** 400 mg/24h o 200 mg/12h	**FG < 20 ml/min:** 200 mg/24h	No hay	No hay	**HD (3 veces por semana): 3**00 mg/24h (después de la sesión) **DP:** 200 mg/24h	No requiere ajuste	
CEFOTAXIMA	**Vía i.v.:** 1 g/8-12h	**FG 10-50 ml/min:** 1 g/8-12h **FG < 10 ml/min:** 1 g/12-24h	**Vía iv.:** 2 g/8h (2 g/4-6h en meningitis)	**FG 10-50 ml/min:** 2 g/6-8h (2g/6h en meningitis) **FG < 10 ml/min:** 1-2 g/12h (2g/12h en meningitis)	**Si dosis específica para indicación 1-2g/8h :** HD y DP: 1-2g/24h **Si dosis específica para indicación 1-2g/6h:** HD y DP: 1-2g/12h **Si dosis específica para indicación 2g/4h:** HD y DP: 2g/12h **TRRC:** dosis como para FG 10-50 ml/min	No requiere ajuste	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
CEFTAROLINA	**Vía iv.**: 600 mg/12h en 1 hora IPPBc	**FG 30-50 ml/min:** 400 mg/12h **FG 15-30 ml/min:** 300 mg/12h **FG < 15 ml/min:** 200 mg/12h	**Vía iv.**: 600 mg/8h en 2 h Bacteriemia o IPPBc por *S.aureus* con CMI>2	**FG 30-50 ml/min:** 400 mg/8h **FG 15-30 ml/min:** 300 mg/8h **FG < 15 ml/min:** 200 mg/8h	**Si dosis recomendada: 600 mg/12h:** HD y DP: 200 mg/12h (después de la sesión). **Si dosis recomendada 600mg/8h:** HD y DP 200mg/8h. **TRRC:** Si dosis recomendada 600mg/12h: HD y DP: 400 mg/12h. Si dosis recomendada 600mg/8h: HD y **DP:** 400 mg/8h.	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Tiempo de infusión:** 2h
CEFTAZIDIMA	**Vía iv.:** 1-2 g/8-12 h	Dosis de carga de 1 g **FG 31-50 ml/min:** 1 g/12h **FG 16-30 ml/min:** 1 g/24h **FG 6-15 ml/min:** 500 mg/24h **FG < 5 ml/min:** 500 mg/48h	**Vía iv.:** 2 g/8h Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I	Dosis de carga de 2 g **FG 31-50 ml/min:** 2 g/12h **FG 16-30 ml/min:** 2 g/24h **FG < 15 ml/min: 1** g/24h	**HD: 500mg -1 g/24h** (administrar después de la sesión de diálisis) **DP:** 1 g/24h **TRRC:** CVVH/CVVHD/CVVHDF: 2 g/8 - 12h o 3 g en infusión continua tras una dosis de carga de 2g.	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Bolo inicial:** 2 g en 30 min **Tiempo de infusión del resto de dosis :** 3h
CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM	**Vía iv.:** 2 g/0,5 g/ 8h en perfusión extendida Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I	**FG 31-50 ml/min:** 1 g/0,25 g/8h **FG 16-30 ml/min:** 0,75 g/0,1875 g/12h **FG 6-15 ml/min:** 0,75 g/0,1875 g/24h **FG < 5 ml/min:** 0,75 g/0,1875 g/48h	Dosis estándar	Dosis estándar	**HD:** 0,75 g/0,1875 g/24h (si toca sesión de diálisis administrar tras ésta) **DP:** 0,75 g/0,1875 g/24h **TRRC:** 1 g/0,25 g/8h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Tiempo de infusión:** 2-3h.

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
CEFTOLOZANO/ TAZOBACTAM	Vía iv.: - 1 g/0,5 g/8h en perfusión extendida en infección intraabdominal e ITU complicadas. Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I - 2 g/1 g/8h en perfusión extendida en neumonía nosocomial, incluyendo asociada a ventilación. Dosis recomendada en neumonía por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I	**FG 30-50 ml/min:** 0,5 g/0,25 g/8h. En neumonía: 1 g/0,5 g/8h **FG 15-29 ml/min:** 0,25 g/0,5 g/8h. En neumonía: 0,5 g/0,25 g/8h **FG < 15 ml/min:** Dosis de carga: 0,5 g/0,25 g. Dosis de mantenimiento: 0,1 g/0,05 g/8h. En neumonía: dosis de carga de 1,5 g/0,75 g y dosis de mantenimiento de 0,3 g/0,15 g/8h	No hay	No hay	**HD:** Dosis de carga: 0,5 g/0,25 g. Dosis de mantenimiento: 0,1 g/0,05 g/8h. En neumonía: dosis de carga de 1,5 g/0,75 g y dosis de mantenimiento de 0,3 g/0,15 g/8h (administrar después de la sesión de diálisis) **TRRC:** HVVC, HDVVC, HDFVV: 1 g/0,5 g/8h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Tiempo de infusión habitual:** 1h, considerar 3h en caso de *Pseudomonas* DTR
CEFTRIAXONA	**Vía iv.:** 1-2 g/24h	**FG < 10 ml/min:** máximo 2 g/24h	**Vía iv.:** 2 g/12h o 4 g/24h - Meningitis	**FG < 10 ml/min:** máximo 2 g/24h	**HD:** Ajustar según filtrado o 2g tras las sesión de diálisis (si CMI<1) **DP:** máximo 2g/24h **TRRC:** No requiere ajuste **ECMO:** 1 g/8h	Si coexisten insuficiencia hepática y renal graves: dosis máxima de 2 g/24h	
	Vía oral: -Amoxicilina/ácido clavulánico 875 mg/8h - Cefuroxima: 500 mg/8-12h - Cefixima: 400 mg/24h o 200 mg/12h - Cefditoreno 400 mg/12h						

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
CEFUROXIMA	**Vía iv.:** 750 mg/8h	**FG 10-20 ml/min:** 750 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 750 mg/24h	**Vía iv.:** 1500 mg/8h	**FG 10-20 ml/min:** 1500 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 1500 mg/24h	**HD:** administrar dosis estándar para un filtrado <10ml/min al final de cada sesión de diálisis **DP:** dosis estándar para un filtrado <10ml/min /48h **TRRC:** 1500 mg/12h iv **ECMO:** 1000 mg/8h	No requiere ajuste	
	Vía oral: 250 mg/12h	**FG 10-29 ml/min:** 250 mg/24h **FG < 10 ml/min:** 250 mg/48h	**Vía oral:** 500 mg/12h	**FG 10-29 ml/min:** 500 mg/24h **FG < 10 ml/min:** 500 mg/48h			
CIPROFLOXACINO	**Vía iv.:** 400 mg/12h	**FG 30-60 ml/min:** 400 mg/12h **FG < 30 ml/min:** 200 mg/12h o 400 mg/24h	**Vía iv.:** 400 mg/8h Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I	**FG 30-60 ml/min:** 400 mg/8h **FG < 30 ml/min:** 400 mg/12h	**HD:** 200-400 mg/24h (el día de la diálisis, después de la sesión) **DP:** 200-400 mg/24h **TRRC:** HVVC, HDFVVC: 200-400 mg/8-12h. Utilizar 400mg/8h cuando CMI>0,5mg/L. **ECMO:** dosis de carga de 800 mg seguido de dosis de manteniento 400-600 mg/8h	No requiere ajuste	
	Vía oral: 500 mg/12h	**FG 31-60 ml/min:** 250 mg/12h **FG < 30 ml/min:** 250 mg/24h	**Vía oral:** 750 mg/12h Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I	**FG 31-60 ml/min:** 500 mg/12h **FG < 30 ml/min:** 500 mg/24h	**HD:** 250-500 mg/24h (el día de la diálisis, después de la sesión) **DP:** 250-500 mg/24h **TRRC**: 250-750mg/12h		
CLARITROMICINA	**Vía iv.:** 500 mg/12h	**FG < 30 ml/min:** 250 mg/12h	No hay	No hay	**Si dosis recomendada 250 mg/12h: HD y DP:** 250mg/24h **Si dosis recomendada es 500mg/12h: HD y DP:** 250mg/12h o 500mg/24h **Si dosis recomendada 1g/24h: HD y DP:** 500mg/24h **TRRC:** Dosificación como CrCl<30ml/min	No debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática grave combinada con insuficiencia renal	
	Vía oral: 250 mg/12h	**FG < 30 ml/min:** 250 mg/24h	**Vía oral:** 500 mg/12h	**FG < 30 ml/min:** 250 mg/12h o 500 mg/24h			

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
CLINDAMICINA	**Vía iv.**: 600 mg/8h	No requiere ajuste	**Vía iv.:** 900 mg/8h	No requiere ajuste	No requiere ajuste	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** evitar dosis elevadas	
	Vía oral: 300 mg/12h		**Vía oral:** 300-450 mg/6h				
CLOXACILINA	**Vía iv.:** 500 mg-1 g/6-8h	**FG < 10 mL/min:** no requiere ajuste específico, pero se recomienda vigilar la aparición de efectos adversos como neurotoxicidad o nefrotoxicidad	**Vía iv.:** 2 g/4h	**FG < 10 mL/min:** no requiere ajuste específico, pero se recomienda vigilar la aparición de efectos adversos como neurotoxicidad o nefrotoxicidad	No requiere ajuste	Reducir la dosis a la mitad si coexisten insuficiencia hepática e insuficiencia renal avanzada	
	Vía oral: 500 mg/4-6h	**FG < 30 ml/min:** 250 mg/4-6h	**Vía oral:** 1 g/6h	**FG < 30 ml/min:** 500 mg/6h			
COLISTINA (COLISTIMETATO SÓDICO)	**Vía iv.:** Dosis de carga: 9 MUI; Dosis de mantenimiento: 4,5 MUI/12 h Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa*	**FG 30-50 ml/min:** 5,5-7,5 MUI/día **FG 10-30 ml/min:** 4,5-5,5 MUI/día **FG < 10 ml/min:** 3,5 MUI/día	No hay	No hay	**HD:** dosis de carga 300mg; dosis de mantenimiento 180 mg días de dialisis y 130 mg días de no diálisis **DP:** dosis carga 300 mg seguido de dosis mantenimiento (pasadas 24 h de dosis de carga) de 150-200mg/24h **TRRC**: dosis de carga 300mg seguido de dosis de mantenimiento (pasadas 12 h de dosis de carga) 220mg cada 12h	No requiere ajuste	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
COTRIMOXAZOL (TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL)	**Vía iv.:** 160/800 mg/12h 8-15mg/kg/día repartidos en 3 dosis	**FG 15-30 ml/min:** reducir la dosis un 50%**FG < 15 ml/min:** reducir la dosis un 25-50%. Usar con precaución.	**Vía iv.:** 240/1200 mg/12h 15-20mg/kg/día repartido en 3-4 dosis (de trimetoprim)	**FG 15-30 ml/min:** reducir la dosis un 50%**FG < 15 ml/min:** reducir la dosis un 25-50%. Usar con precaución.	**HD, DP:** 5-10 mg trimetoprim/kg/12h después de la sesión igual que para FG<15, admin la dosis el día de diálisis tras la sesión**DP:** dosis inicial 160/800 mg seguido de 80/400 mg/12-24 h **TRRC:** no requiere ajuste**ECMO:** 160/800 mg/8 h dosis habituales	**Child-Pugh A y B:** sin cambios**Child-Pugh C:** reducir dosis o evitar su empleo	
	Vía oral: 160/800 mg/12h En profilaxis: 160/800 mg/3 veces a la semana	**FG 15-30 ml/min**: 80/400 mg/12h **FG < 15 ml/min**: no se recomienda su uso. Si es necesario su uso: 40/200 mg-no está comercializado 80/400 mg/12-24h. La dosis para profilaxis no precisa ajuste (160/800mg L-X-V)	**Vía oral:** 240/1200 mg/12h ó 160/800mg/8h	**FG 15-30 ml/min**: 120/600 mg/12h 160/800mg/12h **FG < 15 ml/min**: no se recomienda su uso. Si es necesario su uso: 60/300 mg-120/600 mg/12h 160/800mg/24h			
DALBAVANCINA	**Vía iv.:** 1500 mg como perfusión única o 1000 mg seguidos de 500 mg una semana después	**FG < 30 ml/min:** 1125 mg como dosis única o 750 mg seguidos de 375 mg una semana después	No hay	No hay	No requiere ajuste	**Child-Pugh A:** sin cambios **Child-Pugh B y C:** no se dispone de datos. Administrar con precaución	
DAPTOMICINA	**Vía iv.:** 4-6 mg/kg/24h 8-12 mg/kg/24h en infecciones graves	**FG < 30 ml/min:** dosis habitual/48h. Dosis superiores a 8mg/kg no han sido estudiadas, vigilar estrechamente			**HD:** dosificacion cada 48 horas: igual que para FG<30; dosificacion cada 3 días: dosis habitual y tercera sesión aumentar dosis 50%. Administrar siempre despues sesión. **DP:** igual que para FG<30 **TRRC:** HDVVC: 6 mg/kg/24h; HDFVV: 6-8 mg/kg/24h **ECMO:** 8-10 mg/kg/24h	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** no se dispone de datos. Admistrar con precaución	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
DOXICICLINA	**Vía iv.:** 100 mg/12h **Vía oral:** Dosis de carga: dosis única de 200 mg o dos dosis de 100 mg distanciadas 12h Dosis de mantenimiento: 100 mg/24h. En infecciones graves mantener 100mg/12h.	No requiere ajuste	No hay	No requiere ajuste	No requiere ajuste	No requiere ajuste	
ERITROMICINA	**Vía iv.:** 500-1000 mg/6h **Vía oral:** 250-500 mg/6-8h	**FG < 10 ml/min:** 50% dosis habitual	No hay	No hay	No requiere ajuste	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** evitar dosis elevadas	
ERTAPENEM	**Vía iv.:** 1 g/24h	**FG < 30 ml/min:** 500 mg/24h	No hay	No hay	**HD**: dosis diaria 500 mg/24h (6 horas antes o hasta despues de la sesion) dosis tres veces por semana: 500mg/1g despues de la sesión **DP**:500mg/24h **TRRC**: 1g/24h	No requiere ajuste	
FIDAXOMICINA	**Vía oral:** 200 mg/12 h	No requiere ajuste	No hay	No hay	No requiere ajuste	No requiere ajuste	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
FOSFOMICINA	**Vía iv.:** 4 g/8h 12-24g/día según la indicación repartidos en 3 dosis (máximo 8 g por dosis)	**FG 30-40 ml/min:** 70% dosis estándar **FG 20-30 ml/min:** 60% dosis estándar **FG 10-20 ml/min:** 40% dosis estándar **FG < 10 ml/min:** 20% dosis estándar	**Vía iv.:** 8 g/8h No hay	No hay	**HD: 2**-4 g (el día de la diálisis después de la sesión) **DP:** 2-4 g/48h **TRRC:** 6-8 g/12h	No requiere ajuste	
	Vía oral: 3 g dosis única	**FG < 10 ml/min:** no se recomienda su uso	No hay		No requiere ajuste	No requiere ajuste	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
GENTAMICINA	**Vía iv.:** 6-7 mg/kg/24h	**FG 40-60 ml/min:** 5 mg/kg/24h **FG 20-40 ml/min:** 5-7 mg/kg/48h **FG 10-20 ml/min:** 5 mg/kg/48h **FG < 10 ml/min:** 3 mg/kg/48h	No hay	No hay	**HD: 1-3** mg/kg tres veces por semana tras sesión **DP: 1-3** mg/kg/48-72h **TRRC:** 2-3 mg/kg dosis carga, seguido de 1-1,5mg/kg cada24-36h **ECMO:** dosis de carga estándar. Monitorizar niveles para establecer dosis de mantenimiento	No requiere ajuste	**Monitorizar concentraciones séricas para ajuste de dosis (valorar IC a farmacia)** **Criterios para monitorizar:** función renal inestable o FG elevado (fibrosis quística, politraumatizados, jóvenes…), volumen de distribución alterado (tercer espacio, ascitis, cirrosis, quemados, obesidad, embarazadas, ventilación mecánica),alto riesgo de nefrotoxicidad (>65 años, otros fármacos nefrotóxicos, pacientes críticos), >5 días de tratamiento, objetivo de niveles elevados **Extracción de 1ª muestra:** en 2ª dosis (pico y valle) **Frecuencia de monitorización:** - Pacientes estables y con niveles adecuados: control cada 4 días - Pacientes críticos o tras ajuste de dosis: después de 2-3 días - Si aumento de Cr ≥ 0.5 mg/dL o mala respuesta a la terapia **Nivel valle recomendado:** <1,5mg/L Medir antes de administrar la siguiente dosis **Nivel pico recomendado:** 13-25 mg/L Medir 30 min tras el fin de la infusión de 30 min
IMIPENEM/ CILASTATINA	**Vía iv.:** 500 mg/6h o 1 g/8h	**FG 30-60 ml/min**: 500 mg/8h **FG 15-30 ml/min:** 500 mg/12h **FG < 15 ml/min**:no administrar a menos que se instaure hemodiálisis en el plazo de 48h	**Vía i.v.:** 1 g/6h Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I	**FG 30-60 ml/min**: 500 mg/6h **FG 15-30 ml/min:** 250 mg/6h **FG < 15 ml/min**:no administrar a menos que se instaure hemodiálisis en el plazo de 48h	**HD:** 250-500mg/12h **DP: 250-**500 mg/12h **TRRC:** HVVC, HDVVC, HDFVVC: 1g dosis de carga, seguido de 250mg/6h o 500mg/6-8h **ECMO:** 1 g/6h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Tiempo de infusión:** 3h Bolo inicial: 500-1000 mg en 30 min en sepsis

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
LEVOFLOXACINO	**Vía iv.:** 500 mg/24h **Vía oral:** 500 mg/24h	Dosis inicial: 500 mg **FG 20-50 ml/min:** 250 mg/24h **FG 10-19 ml/min:** 125 mg/24h ó 250mg/48h **FG < 10 ml/min:** 125 mg/24h ó 250mg/48h	**Vía iv.: 500 mg/12h** **- Dosis recomendada en infecciones por Pseudomonas aeruginosa con sensibilidad I** **- Neumonía adquirida en la comunidad** **- IPPBs** **Vía oral: 500 mg/12h ó 750mg/24h** - Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I - Neumonía adquirida en la comunidad - IPPBs	Dosis inicial 500 mg **FG 20-50 ml/min:** 250 mg/12h ó 750mg/48h **FG 10-19 ml/min:** 125 mg/12h 750mg dosis inicial 500mg/48h o 250mg/24h **FG < 10 ml/min:** 125 mg/24h 750mg dosis inicial 500mg/48h o 250mg/24h	Si dosis recomendada **250mg/24h: HD y DP:** 250mg/48h Si dosis recomendada **500mg/24h: HD y DP:** dosis de carga 500mg seguido de 250mg/48h o 125mg/24h Si dosis recomendada **750mg/24h: HD y DP:** 750mg dosis de carga, seguido de500mg/48h o 250mg/24h **TRRC:** Si dosis recomendada **250mg/24h** no requiere ajuste, si dosis recomendada **500mg/24h:** dosis de carga 500mg seguido de 250mg/24h po 500mg/48h, si dosis recomendada **750mg/24h:** dosis carga 750mg seguido de 500mg/24h o 750mg/48h	No requiere ajuste	
LINEZOLID	**Vía iv.:** 600 mg/12h **Vía oral:** 600 mg/12h	No requiere ajuste	No hay	No hay	**HD:** el día de la diálisis administrar después de la sesión **ECMO:** 600 mg/8-12h iv	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** utilizar con precaución y controlar la trombocitopenia	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
MEROPENEM	**Vía iv.:** 500 mg-1 g/8h	**FG 26-50 ml/min:** 1 g/12h **FG 10-25 ml/min:** 500 mg/12h **FG < 10 ml/min:** 500 mg/24h	**Vía iv.**: 2 g/8h en perfusión de 3h - Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I - Infecciones broncopulmonares en fibrosis quística - Meningitis bacteriana	**FG 26-50 ml/min:** 2 g/12h **FG 10-25 ml/min:** 1 g/12h **FG < 10 ml/min:** 1 g/24h	Si dosis recomendada **1g/8h: HD y DP:** 500mg/24h Si dosis recomendada **2g/8h: HD y DP:** 1g/24h o 500mg/12h **TRRC**: infusion **intermitete** dosis carga 1g seguido de 500mg-1g/8h infusion **continua** dosis carga 1g seguido de 1g en 12h cada 12h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Bolo inicial:** 2 g en 30 min **Tiempo de infusión de la siguiente dosis:** 3h
MEROPENEM/ VABORBACTAM	**Vía iv.:** 2 g/2 g/8h en perfusión extendida	**FG 20-39 ml/min:** 1 g/1 g/8h en perfusión de 3 horas **FG 10-19 ml/min:** 1 g/1 g/12 h en perfusión de 3 horas **FG < 10 ml/min:** 0,5 g/0,5 g/12 h en perfusión de 3 horas	No hay	No hay	**HD:** 1g/12h (cuando coincida con día de diálisis administrar una de las dos dosis tras la sesion) **DP**:1g/12h **TRRC:** 2g/12h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Tiempo de infusión:** 3h
METRONIDAZOL	**Vía iv.:** 500 mg/8h o 1000 mg-1500 mg diarios como dosis única **Vía oral:** 250-750 mg/8-12h	No requiere ajuste	**Vía iv.:** 500 mg/8h **Vía oral:** 500 mg/8h	No requiere ajuste	**HD**: 500mg/8-12h **DP y TRRC** no requiere ajuste	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** la dosis debe reducirse a la mitad	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
MOXIFLOXACINO	**Vía iv.:** 400 mg/24h **Vía oral:** 400 mg/24h	No requiere ajuste	No hay	No hay	No requiere ajuste	No requiere ajuste	
PENICILINA G	**Vía iv.:** 600 mg (1 MU)/6h	**FG 10-30 ml/min**: 1 MU/8h **FG < 10 ml/min:** 1 MU/12h	**Vía iv.:** 1200 mg (2 MU)/4-6h	**FG 10-30 ml/min**: 2 MU/8h **FG < 10 ml/min:** 2 MU/12h	**HD:**el 100% de la dosis habitual la primera dosis, luego 25-50% de la dosis habitual en perfusión continua o cada 4-6 h **DP:** igual que FG<10 **TRRC:** el 100% de la dosis habitual la primera dosis, luego 50-75% de la dosis habitual en perfusión continua o cada 4-6 h	No requiere ajuste	
	Vía oral: Amoxicilina 500 mg/8h						
PENICILINA V	**Vía oral:** 500 mg/6h	**FG 10-30 ml/min:** 250-500 mg/8h **FG < 10 ml/min:** 250-500 mg-12h	No hay	No hay	**HD:** 500 mg/12h (después de la sesión) **DP:** 500 mg/12h	No requiere ajuste	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
PIPERACILINA/ TAZOBACTAM	**Vía iv.:** 4 g/0,5 g/8h en perfusión extendida de 3-4h ó 4g/0,5g/6h en perfusión de 30 min	**FG 20-40 ml/min:** Dosis máxima sugerida: 4 g/0,5 g/8h **FG < 20 ml/min:** Dosis máxima sugerida: 4 g/0,5 g/12h	**Vía iv.:** 4 g/0,5 g/6h en perfusión extendida de 3-4h - Dosis recomendada en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* con sensibilidad I - Neumonía grave - Neutropenia febril con sospecha de infección	**FG 20-40 ml/min**: 4 g/0,5 g/8h **FG < 20 ml/min:** 4 g/0,5 g/12h	**HD:** 4 g/0,5 g/12ho 2 g/0,25 g/8h después de la sesion **DP:** 4 g/0,5 g/12h o 2/0,25g/8h **TRRC:** HVVC, HDVVC, HDFVVC: 4 g/0,5 g/8h o 4 g/0,5 g dosis de carga seguido de 2/0,25g/6h **ECMO:** dosis de carga de 4 g/0,5 g en 20-30 min. Dosis de mantenimiento 4 g/0,5 g/6h en perfusión de 3-4h	No requiere ajuste	**PERFUSIÓN EXTENDIDA:** **Bolo inicial:** 4/0,5 g en 30 min **Tiempo de infusión de la siguiente dosis:** 3-4h
RIFAMPICINA	**Vía iv.:** 600 mg/24h **Vía oral:** 600 mg/24h	No requiere ajuste	No hay	No hay	No requiere ajuste	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** disminuir la dosis (también en ictericia obstructiva)	

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
TEICOPLANINA	**Vía iv.:** Dosis de carga: 6 mg/kg/12h durante 3 dosis (en infección osteoarticular y endocarditis 3-5 dosis) Dosis de mantenimiento: 6 mg/kg/24h	Dosis de carga sin cambios **FG 30-80 ml/min:** 3 mg/kg/24h o 6 mg/kg/48h **FG < 30 ml/min:** 1 mg/kg/24h o 6 mg/kg/72h	**Vía iv.:** Dosis de carga: 12 mg/kg/12h durante 3-5 dosis Dosis de mantenimiento: 12 mg/kg/24h	Dosis de carga sin cambios **FG 30-80 ml/min:** 6 mg/kg/24h o 12 mg/kg/48h **FG < 30 ml/min:** 2 mg/kg/24h o 12 mg/kg/72h	Dosis de carga sin cambios **HD:** 1/3 de dosis habitual/24h o dosis habitual/72h **DP:** 6 mg/kg/48h **TRRC:** HVVC: Dosis de carga de 1200 mg seguida de 400 mg/24h; HDVVC: Dosis de carga de 800 mg, seguida de 400 mg/48h **ECMO:** dosis de carga 12 mg/kg/12h (3 dosis) seguido de 12 mg/kg/24h	No requiere ajuste	
	Vía oral: Linezolid 600 mg/12h						
TIGECICLINA	**Vía iv.:** dosis de carga de 100 mg, seguida de 50 mg/12h	No requiere ajuste	No hay	No hay	No requiere ajuste	**Child-Pugh A y B:** sin cambios **Child-Pugh C:** la dosis debe reducirse a la mitad: 25 mg/12 h, administrados tras la dosis inicial de 100 mg	En caso de microorganismos multiR produciendo infección grave, se recomienda una dosis de carga de 200mg seguido de 100mg/12h

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
TOBRAMICINA	Vía iv.: 6-7 mg/kg/24h Dosis recomendada en infecciones por Pseudomonas aeruginosa	**FG 40-60 ml/min:** 5 mg/kg/24h **FG 20-40 ml/min:** 5-7 mg/kg/48h **FG 10-20 ml/min:** 5 mg/kg/48h **FG < 10 ml/min:** 3 mg/kg/48h	No hay	No hay	**HD:** 2-3mg/kg dosis carga seguido 1-2 mg/kg/48-72h después de la sesión DP: 3-5 mg/kg/48h **TRRC:** dosis de carga de 2-3 mg/kg seguido de 1-2,5 mg/kg/24-48h **ECMO:** dosis de carga de 7-10 mg/kg a intervalo ajustado a función renal	No requiere ajuste	**Monitorizar concentraciones séricas para ajuste de dosis** **(valorar IC a farmacia)** **Criterios para monitorizar:** función renal inestable o FG elevado (fibrosis quística, politraumatizados, jóvenes…), volumen de distribución alterado (tercer espacio, ascitis, cirrosis, quemados, obesidad, embarazadas, ventilación mecánica),alto riesgo de nefrotoxicidad (>65 años, otros fármacos nefrotóxicos, pacientes críticos), >5 días de tratamiento, objetivo de niveles elevados **Extracción de 1ª muestra:** en 2ª dosis (pico y valle) **Frecuencia de monitorización:** - Pacientes estables y con niveles adecuados: control cada 4 días - Pacientes críticos o tras ajuste de dosis: después de 2-3 días - Si aumento de Cr ≥ 0.5 mg/dL o mala respuesta a la terapia **Nivel valle recomendado:** <1mg/L Medir antes de administrar la siguiente dosis **Nivel pico recomendado:** 10-12 ó 16-20 mg/L según el foco Medir 30 min tras el fin de la infusión de 30 min

ANTIBIÓTICO	DOSIS ESTANDAR (S)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL	DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE INSUFICIENCIA RENAL DOSIS INCREMENTADAS (I)	AJUSTE DIÁLISIS/TERAPIAS REEMPLAZO RENAL	AJUSTE INSUFICIENCIA HEPÁTICA	OBSERVACIONES
VANCOMICINA	**Vía iv.:** 15-20 mg/kg/8-12h (no exceder 2 g por dosis) Puede emplearse una dosis de carga de 25-30 mg/kg (máximo 3g)	Dosis de carga de 20-25 mg/kg **FG 50-90 ml/min:** 15-20 mg/kg/12h **FG 15-50 ml/min:** 10-15 mg/kg/24h **FG < 15 ml/min:** 10-15 mg/kg/48-72h	No hay	No hay	**HD:** **Dosis administradas tras finalizar diálisis:** Dosis de carga: 25 mg/kg - Membrana de baja permeabilidad: dosis de mantenimiento: 7,5 mg/kg - Membrana de alta permeabilidad: dosis de mantenimiento: 10 mg/kg **Dosis intradialíticas:** Dosis de carga: 30-35 mg/kg - Membrana de baja permeabilidad: dosis de mantenimiento: 7,5-10 mg/kg - Membrana de alta permeabilidad: dosis de mantenimiento: 10-15 mg/kg **DP:** Dosis de carga: 20-25 mg/kg. Dosis de mantenimiento: 10-15 mg/kg **TRRC:** Dosis de carga: 20-25mg/kg Dosis de mantenimiento: 7,5-10 mg/kg/12h **ECMO:** Dosis de carga: 30 mg/kg en 4h. Dosis de mantenimiento: 30-40 mg/kg/día	No requiere ajuste	**Monitorizar concentraciones séricas para ajuste de dosis** **(valorar IC a farmacia)** **Criterios para monitorizar:** función renal inestable, >5 días de tratamiento, riesgo de nefrotoxicidad (>65 años, otros fármacos neurotóxicos, pacientes críticos. **Extracción de 1ª muestra:** - Función renal normal: inmdiatamente antes de 4ª dosis. - IR: antes de 2ª-3ª dosis **Frecuencia de monitorización:** - Pacientes estables y con niveles adecuados: control semanal - Pacientes críticos o tras ajuste de dosis: después de 2-3 días - Si aumento de Cr ≥ 0.5 mg/dL o mala respuesta a la terapia **Nivel valle recomendado:** - 15-20 mg/L en infecciones complicadas: bacteriemia por S. aureus MR, E. faecium , endocarditis, osteomielitis (puede necesitar valles mayores: 20-30 mg/L), meningitis, neumonía por *S. aureus* - 10-15 mg/L para otras infecciones Medir antes de administrar la siguiente dosis **Nivel pico recomendado:** 20-40 mg/L No es necesaria su medición en la práctica habitual. 2 horas después de finalizar infusión de una hora
	Vía oral: 125 mg/6h Exclusivamente para *C.difficle*	No requiere ajuste			No requiere ajuste		

EUCAST: I - Susceptible, exposición aumentada*: Un microorganismo se clasifica como «Susceptible, exposición aumentada*» cuando existe una alta probabilidad de éxito terapéutico cuando la exposición al agente aumenta al ajustar el régimen de dosificación o su concentración en el lugar de la infección.

LEYENDA

API: agua para inyección
BDP: biodisponibilidad
DP: diálisis peritonea
ECMO: Oxigenador de membrana extracorpóreo
FG: filtrado glomerular
IC: interconsulta
HVVC: hemofiltración venosa-venosa continua
HDVVC: hemodiálisis venosa-venosa continua
HDFVVC: hemodiafiltración venosa-venosa continua
HD: hemodiálisis
iv: intravenosa
IR: insuficiencia renal
MUI: millones de unidades internacionales
RL: Ringer lactato
SF0,9%: suero fisiológico 0,9%
SG5%: suero glucosado 5%
SGS: suero glucosalino
TDE: terapia de depuración extracorpórea
TRRC: técnicas de reemplazo renal continuo

BIBLIOGRAFÍA

- Fichas técnicas AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
- Antibioterapia Hospital Virgen de la Macarena: https://antibioterapia.hospitalmacarena.es/
- EUCAST: https://www.eucast.org/
- Guía PRIOAM: https://www.guiaprioam.com/
- UpToDate
- J.Mensa, A.Soriano; Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2024
- https://proantibioticos.com/administracion-de-b-lactamicos-en-perfusion-continuainfusion-prolongada/
- https://www.saludcastillayleon.es/CAZamora/es/comisiones-hospitalarias/grupo-proa-za.ficheros/2613686-Betalact%C3%A1micos_Perfusi%C3%B3n_Extendida_PROAZA.pdf
- https://www.hospitaltorrecardenas.es/wp-content/uploads/2024/06/Dosis-incrementadas-antibioterapia-EUCAST.pdf

BIODISPONIBILIDAD Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

ANTIBIÓTICO	BIODISPONIBILIDAD ORAL	FORMA DE ADMINISTRACIÓN
AMOXICILINA	70 %	Independiente de alimentos
AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO	70 %	Independiente de alimentos
AZITROMICINA	37 %	Independiente de alimentos
CEFDITORENO	15-20%	Administrar CON alimentos
CEFIXIMA	40-50%	Independiente de alimentos
CEFUROXIMA	52 %	Administrar CON alimentos
CIPROFLOXACINO	70-80%	No administrar con productos lácteos ni con zumo de frutas enriquecidos en minerales. Absorción más rápida con el estómago vacío
CLARITROMICINA	50 %	Independiente de alimentos
CLINDAMICINA	90 %	Independiente de alimentos
CLOXACILINA	43 %	Administrar en AYUNAS
COTRIMOXAZOL (TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL)	99 %	Independiente de alimentos
DOXICICLINA	90-95%	Independiente de alimentos
ERITROMICINA	35-75%	Independiente de alimentos
FOSFOMICINA	33-53%	Administrar en AYUNAS
LEVOFLOXACINO	100 %	Independiente de alimentos. Tomar 2 horas antes o después de la administración de sales de hierro, sales de zinc, antiácidos que contengan magnesio o aluminio y de sucralfato
LINEZOLID	100 %	Independiente de alimentos
METRONIDAZOL	90-100%	Independiente de alimentos
MOXIFLOXACINO	91 %	Independiente de alimentos
PENICILINA V	60 %	Administrar en AYUNAS
RIFAMPICINA	90-95%	Administrar en AYUNAS

BIBLIOGRAFÍA

- Fichas técnicas AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
- Grupo PROA Hospital 12 de Octubre: Recomendacion de pautas de mantenimiento equivalentes en terapia secuencial

AJUSTES EN FUNCIÓN DEL PESO CORPORAL

Principio activo	RECOMENDACIÓN
ACICLOVIR	PIA
AMIKACINA	PIA para el cálculo de la primera dosis, para posteriores ajustar según niveles plasmáticos
AMOXICILINA	Dosis habitual máxima
AMOXICILINA/CLAVULANICO	Dosis habitual máxima
AMPICILINA	Dosis habitual máxima
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL	PIA. En infecciones graves o pacientes críticos, utilizar PCT (dosis máxima diaria 600mg)
AZITROMICINA	NA
AZTREONAM	NA
BENCILPENICILINA	NA
BENCILPENICILINA BENZATINA	NA
BEZLOTOXUMAB	NA
CASPOFUNGINA	En pacientes con un peso >80 kg, dosis de mantenimiento de 70mg
CEFADROXILO	NA
CEFAZOLINA	2g/8h administrados en perfusión continua
CEFDITORENO	NA
CEFEPIMA	2g/8h administrados en perfusión durante 3-4 h
CEFIDEROCOL	NA
CEFOTAXIMA	NA
CEFOXITINA	NA
CEFTAROLINA	NA
CEFTAZIDIMA	2g/8h administrados en perfusión continua
CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM	NA
CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM	NA
CEFTRIAXONA	2g/12h
CEFUROXIMA	NA
ISONIAZIDA/PIRIDOXINA	NA
CIDOFOVIR	PIA
CIPROFLOXACINO	Dosis habitual máxima
CLARITROMICINA	NA
CLINDAMICINA	Dosis habitual máxima
CLOXACILINA	Dosis habitual máxima
COLISTIMETATO DE SODIO	NA
DALBAVANCINA	Dosis estándar
DAPTOMICINA	PIA
DOXICICLINA	Dosis estándar
ERITROMICINA	Dosis estándar

ERTAPENEM	Dosis estándar. Considerar 2g/24h si CMI >0,25 mg/ml
ESTREPTOMICINA	PIA
ETAMBUTOL	NA
FAMCICLOVIR	NA
FENOXIMETILPENICILINA	NA
FLUCONAZOL	En candidiasis, utilizar PCT (dosis máximas de carga 1,6 g y mantenimiento 800 mg/día)
FOSCARNET	PIA
FOSFOMICINA	Fosfomicina trometamol: dosis habituales. Fosfomicina sódica: dosis máxima 24g diarios repartidos en 3-4 dosis
GANCICLOVIR	PIA
GENTAMICINA	PIA para el cálculo de la primera dosis, para posteriores ajustar según niveles plasmáticos
IMIPENEM/CILASTATINA	NA
ISAVUCONAZOL	NA
ISONIAZIDA	NA
ITRACONAZOL	NA
JOSAMICINA	NA
LEVOFLOXACINO	NA
LINEZOLID	Dosis habitual. Si filtrado glomerular de 60-129 mL/min y edad < 60años, considerar una dosis de carga de 600 mg, después 450 mg cada 8 horas. Dosis de 600mg/8h no se recomiendan sin monitorización de niveles por el elevado riesgo de mielosupresión.
MEROPENEM	Si CrCl ≥130 mL/min/1.73 m2, administrar en infusión prolongada (2g cada 8h durante 3h)
METRONIDAZOL	Dosis habitual máxima
MICAFUNGINA	Para C.albicans: si peso<120kg 150mg/24h, peso>120kg 200mg/24h. Otras candidiasis: 200mg /24h.
MICONAZOL	NA
MOXIFLOXACINO	NA
NORFLOXACINO	NA
OSELTAMIVIR	Dosis habitual
PIPERACILINA/TAZOBACTAM	4,5g cada 8h (en infusión prolongada de 4h) o 4,5g cada 6h (en infusiones de 30 min). Si CrCl=100-150 ml/min: 4,5g IV cada 6h en infusión prolongada de 4h.
PIRAZINAMIDA	NA
POSACONAZOL	NA
REMDESIVIR	NA
RIFAMPICINA	NA
RIFAXIMINA	NA
SULFADIAZINA	NA
SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM	PIA
TEICOPLANINA	PCT
TIGECICLINA	NA
TOBRAMICINA	PIA para el cálculo de la primera dosis, para posteriores ajustar según niveles plasmáticos

VALACICLOVIR	NA
VALGANCICLOVIR	NA
VANCOMICINA	PCT para el cálculo de la dosis de carga (máximo 3g) y de mantenimiento (4,5g al día, sin superar los 2g por dosis). Monitorizar según niveles plasmáticos.
VORICONAZOL	PIA por vía IV. Por vía oral, dosis estándar.

Última revisión: Septiembre 2024

Fórmulas
HOMBRES: 50 kg + 0,75 x (altura en cm – 152,4)
MUJERES: 45,5 kg + 0,67 x (altura en cm – 152,4)
PIA=PCI+Cx(PCT-PCI)
C: coeficiente C=0,4 para todos los fármacos (excepto para el ciprofloxacino C=0,45)

Leyenda	
PCI	Peso corporal ideal
PIA	Peso ideal ajustado
PCT	Peso corporal total
NA	No existe recomendación posológica en obesos, dosis habitual

BIBLIOGRAFÍA
Stanford Health Care Antimicrobial Dosing Guide for Obesity
Castro-Baladó et al. Updated antimicrobial dosing recommendations for obese patients
Guía Mensa 2024
Uptodate

CALCULADORA DE DOSIS DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN ALTURA Y PESO

El presente enlace lleva a una calculadora que permite calcular la dosificación de antimicrobianos en función de diversos parámetros. Para acceder, pinchar en el enlace:

Calculadora